

TEMA 4.9 • GASTROENTEROLOGÍA

Cáncer de Esófago, Gástrico, Colon y Recto

PERFIL EUNACOM 1.06.1.004

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Cáncer del Tubo Digestivo

Cubre: cáncer de esófago, cáncer gástrico, cáncer de colon y cáncer de recto.

Características Compartidas (lo más importante)

Clínica común

- Todos pueden producir:
- **Baja de peso** (signo de alarma universal)
- **Hemorragia digestiva:** alta (esófago/estómago) o baja (colon/recto) → **Anemia: Generalidades|anemia ferropénica**
- **Signos de alarma ABCD:** Anemia, Baja de peso, Cambio de síntomas, Disfagia

Diagnóstico

TABLA 4.9.1: CÁNCER VS EXAMEN DIAGNÓSTICO

CÁNCER	EXAMEN DIAGNÓSTICO
Esófago / gástrico	Endoscopia digestiva alta + biopsia
Colon / recto	Colonoscopia + biopsia
Todos	TAC de tórax-abdomen-pelvis (etapificación)

Factor pronóstico principal

Invasión transmural (qué tan profundo penetra el tumor en la pared) → no las adenopatías ni las metástasis.

Tratamiento

- **Único curativo:** cirugía
- Quimioterapia y/o radioterapia adyuvante según caso

Cáncer de Esófago

- **Clínica:** disfagia lógica (sólidos → líquidos) + baja de peso
- **FR: tabaquismo** (carcinoma escamoso), RGE/Barrett (adenocarcinoma)
- **Etapificación extra:** endosonografía transesofágica (invasión transmural pre-quirúrgica)
- **Radioterapia:** especialmente útil en cáncer de esófago (al igual que en cáncer de recto)

Cáncer Gástrico

EUNACOM CRITERIOS

Cáncer gástrico = 1ª causa de muerte por cáncer en hombres en Chile. 2ª en mujeres (después de mama).

- Da síntomas tardíamente → avanzado al diagnóstico → mal pronóstico
- **Causa principal:** H. pylori
- **FR:** metaplasia gástrica, gastritis atrófica, antecedente familiar

Formas de presentación clínica

TABLA 4.9.2: PRESENTACIÓN VS CLAVE DIAGNÓSTICA

PRESENTACIÓN	CLAVE DIAGNÓSTICA
Síndrome pilórico	Vómitos postprandiales proyectivos en aumento → cáncer hasta demostrar lo contrario
Masa epigástrica palpable	Tumor grande
Epigastralgia urente	Igual a úlcera → siempre endoscopia
Adenopatía supraclavicular	Signo de Virchow (metástasis)

Clasificación

TABLA 4.9.3: TIPO VS PROFUNDIDAD

TIPO	PROFUNDIDAD	TRATAMIENTO
Incipiente	Hasta submucosa	Cirugía
Avanzado	Muscular propia o más allá	Cirugía + quimioterapia ± radioterapia

Diagnóstico

- Endoscopia digestiva alta + biopsia

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Caso EUNACOM: Paciente de 60 años con baja de peso de 10 kg + dolor epigástrico → sospecha cáncer gástrico → pedir **endoscopia**. Si además tiene ictericia → cambiar sospecha a **cáncer de páncreas** → pedir **TAC**.

Cáncer de Colon

- **Síntoma más frecuente:** constipación (en adulto mayor = cáncer de colon hasta descartar)
- **Complicación más frecuente:** obstrucción intestinal (1ª causa de obstrucción del colon)
- **Marcador tumoral:** CEA (antígeno carcinoembrionario) → solo útil para **seguimiento**, NO diagnóstico ni pronóstico
- **Quimioterapia:** más eficaz que en otros cánceres digestivos; puede usarse con intención curativa incluso con metástasis hepáticas reseables
- **Cirugía:** se hace siempre (incluso en estadios avanzados para evitar obstrucción)

Cirugía mínima

- Tumor derecho → **hemicolecotomía derecha**
- Tumor izquierdo → **hemicolecotomía izquierda**

Formas genéticas

TABLA 4.9.4: FORMA VS CARACTERÍSTICAS

FORMA	CARACTERÍSTICAS	RIESGO	CONDUCTA
HNPCC (Lynch)	Pocos pólipos (< 10)	Alto	Seguimiento colonoscópico
PAF (Poliposis adenomatosa familiar)	> 100 pólipos (a veces > 50)	100% evoluciona a cáncer	Colectomía total profiláctica

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Si en la colonoscopia hay **incontables pólipos** → la conducta es **colectomía total** profiláctica (PAF).

Pólipos de colon

TABLA 4.9.5: TIPO VS RIESGO MALIGNO

TIPO	RIESGO MALIGNO	CONDUCTA
Hiperplásico	Ninguno	Observar (no es premaligno)
Adenomatoso	Alto	Resección + colonoscopia de control cada 1-3 años
Adenomatoso vellosos	Máximo	Resección + seguimiento estricto

Cáncer de Recto

- **FR:** VIH, VPH (mismo virus que cáncer cervicouterino/vulvar/peneano), colitis ulcerosa
- **Clínica:** disquecia (defecación dolorosa o difícil), deformación del bolo fecal, hematoquecia
- **Peculiaridad:** puede dar **metástasis pulmonares sin metástasis hepáticas previas** (drenaje por vena cava inferior, no porta)

Etapificación

- TAC de tórax (metástasis pulmonares precoces)
- Endosonografía rectal
- Resonancia magnética de pelvis

Tratamiento

- Cirugía + **radioterapia** (igual que cáncer de esófago)
- Complicación de la radioterapia: **rectitis actínica** (pujo, tenesmo, mucosidad, hematoquecia)

Casos Clínicos Tipo EUNACOM

TABLA 4.9.6: CASO VS DIAGNÓSTICO		
CASO	DIAGNÓSTICO	CONDUCTA
80 años, anemia + constipación	Cáncer de colon	Colonoscopia
60 años, baja de peso + epigastralgia	Cáncer gástrico	Endoscopia alta
60 años + baja de peso + epigastralgia + ictericia	Cáncer de páncreas	TAC
59 años fumador + disfagia progresiva	Cáncer de esófago	Endoscopia alta
68 años + vómitos postprandiales + baja de peso	Cáncer gástrico (síndrome pilórico)	Endoscopia alta
65 años + constipación 6 meses + obstrucción intestinal	Cáncer de colon obstructivo	Manejo de obstrucción (cirugía)

| 57 años + VIH + hematoquecia + disquecia | Cáncer de recto | Colonoscopia/rectoscopia + biopsia |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de 75 años con constipación de 4 meses de evolución y anemia ferropénica. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica y el examen a solicitar?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Cáncer de Esófago, Gástrico, Colon y Recto. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Cánceres digestivos: diagnóstico con endoscopia/colonoscopia + biopsia; etapificación con TAC; pronóstico por invasión transmural
- Cáncer gástrico: primera causa de muerte por cáncer en hombres en Chile; asociado a H. pylori
- Cáncer de colon: constipación es síntoma más frecuente; obstrucción intestinal es complicación más frecuente
- PAF (>100 pólipos): 100% evoluciona a cáncer → colectomía total profiláctica
- Pólipos: hiperplásico = benigno; adenomatoso = riesgo de cáncer → seguimiento cada 1-3 años
- ACE: solo para seguimiento post-cirugía, no para diagnóstico
- Cáncer de recto: VIH/VPH/colitis ulcerosa; metástasis pulmonares sin hepáticas; TAC tórax obligatorio
- Cáncer de colon: cirugía siempre (incluso avanzados); quimioterapia responde bien

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (CÁNCER DE ESÓFAGO, GÁSTRICO, COLON Y RECTO)

PREGUNTA 1

Paciente de 75 años con constipación de 4 meses de evolución y anemia ferropénica. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica y el examen a solicitar?

- A) Constipación funcional; trimebutino
- B) Cáncer de colon; colonoscopia
- C) Hipotiroidismo; TSH
- D) Síndrome de intestino irritable; educación
- E) Enfermedad diverticular; TAC

PREGUNTA 2

En una colonoscopia se encuentran más de 100 pólipos en el colon de un paciente de 30 años. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A) Seguimiento colonoscópico anual
- B) Polipsectomía de los más grandes
- C) Colectomía total profiláctica
- D) Quimioterapia preventiva
- E) Control con ACE semestral

PREGUNTA 3

Paciente de 55 años con cáncer de recto confirmado. ¿Cuál de los siguientes exámenes es especialmente importante en la etapificación?

- A) TAC de abdomen solamente
- B) TAC de tórax
- C) Ecografía hepática
- D) PET-CT
- E) Cintigrafía ósea

RESUMEN: CÁNCER DE ESÓFAGO, GÁSTRICO, COLON Y RECTO

Clase sobre los cánceres del tubo digestivo. En común: baja de peso, hemorragia, anemia ferropénica; diagnóstico con endoscopia/colonoscopia + biopsia; etapificación con TAC; pronóstico por invasión transmural; tratamiento quirúrgico. Cáncer de esófago: disfagia lógica, cigarrillo/Barrett. Cáncer gástrico: primera causa de muerte por cáncer en hombres en Chile, asociado a H. pylori, síndrome pilórico o epigastralgia. Cáncer de colon: constipación como síntoma más frecuente, obstrucción intestinal como complicación, marcador ACE, formas genéticas (HNPCC, PAF). Cáncer de recto: VIH, VPH, colitis ulcerosa; metástasis pulmonares sin hepáticas; radioterapia importante.